仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“汎生”舒復靜脈注射劑（西華崙隆）/ Cefin for IV injection “Panbiotic”(Ceftriaxone)
衛生福利部食品藥物管理署給證號碼	衛署藥製字第038615號 G-2639
申請廠商	臺灣汎生製藥廠股份有限公司

頭孢子菌素類抗生素

“汎生”

舒復靜脈注射劑（西華崙隆）

Cefin for IV injection “Panbiotic” (Ceftriaxone)

衛署藥製字第038615號 G-2639

(1)未滿28（≦28）天的新生兒正以靜脈注射方式接受含鈣藥品及營養品，則這些新生兒不應再投予Ceftriaxone 成分之注射劑。(2)大於28（＞28）天以上的病人，可以相繼使用含Ceftriaxone與含鈣藥品，但是輸注管必須完全以可相容的溶液沖洗。(3)Ceftriaxone與含鈣藥品不應以Y型管同時投予病人。(4)因為Ceftriaxone-calcium沈澱發生於大於28（＞28）天以上的病人之風險很小，因此這些病人可以同時使用Ceftriaxone與含鈣產品，但必須遵循前述指示使用。另外不可以將Ceftriaxone與含鈣產品，包括Ringer’s或Hartmann’s溶液或非口服方式之含鈣營養品等混合使用。根據體外研究結果發現，如果遵循前述注意事項使用Ceftriaxone與含鈣溶液或其產品，發生Ceftriaxone-calcium沈澱的風險很低。(5)目前並沒有資料顯示靜脈輸注Ceftriaxone與口服含鈣產品或肌肉注射Ceftriaxone與靜脈注射或口服含鈣產品之間不會發生沈澱。

廣效的cephalosporin抗生素製劑

1. 說明

1.1 治療/藥理分類

本品是一作用時間長，且廣效的注射用cephalosporin抗生素製劑

1.2 成份含量

主成份：ceftriaxone 雙鈉鹽。

每小瓶含：

Ceftriaxone (as Disodium 3.5 H2O) 0.25克；0.5克；1克；2克 (Potency)

2. 臨床特性

2.1 適應症

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

說明：適應症屬所述之感染症，例如：敗血症；腦膜炎；擴散性莱姆病(包括早期及晚期)；腹部感染症(包括腹膜炎、膽道及胃腸道感染)；骨、關節、軟組織、皮膚及傷口之感染；免疫機能受損之感染病患；腎臟及泌尿道之感染；呼吸道感染(特別是肺炎、耳鼻喉之感染)；生殖器感染(包括淋病)。

2.2 用法和用量

標準劑量

成人和12歲以上的孩童。

一般劑量爲Ceftriaxone 1-2克，每天一次（每24小時）。在嚴重的感染或致病菌對Ceftriaxone的感受性僅是中等時，其劑量可能增加到4 克，一天給藥一次。

治療期間

療程會因疾病的進程而改變，以抗生素療法的一般原則而言，在病人退熱或經證實已根絕細菌後，Ceftriaxone仍需繼續投藥至少48-72小時。

合併療法

由實驗得知Ceftriaxone和laminoglycosides配合使用時，對革蘭氏陰性細菌有協同殺菌作用，雖然這種合併療法的協同作用不一定會發生，但對一些微生物如*Pseudomonas aeruginosa*所導致嚴重而有生命危險的感染時，仍必需考慮使用此種合併療法。因兩藥物在物理性上的不相容，投藥時須依建議劑量分開使用。

使用方法

通常溶液在調配完成後，應立即使用。

配製後之溶液，在室溫下，物理和化學的穩定性可維持6小時（或在2-8℃的冰箱下可達24小時）。依據調配濃度和貯存時間的不同，溶液顏色會呈淡黃色至琥珀色，溶液顏色並不影響本藥的效價和耐受性。

靜脈注射：靜脈注射時，Ceftriaxone 250 mg或500 mg溶於5 ml，或Ceftriaxone 1 g溶於10 ml的滅菌注射用水。靜脈注射的時間要超過2-4分鐘。

靜脈輸注：輸注時間至少須30分鐘。

不可使用含鈣溶液(例如 Ringer’s 溶液或 Hartmann’s 溶液)配製Ceftriaxone小瓶或進一步稀釋已配製後之小瓶，因爲會產生沉澱。當Ceftriaxone與含鈣溶液在同一個靜脈注射管線混合時，也會發生 ceftriaxone-calcium 沉澱。Ceftriaxone不應與含鈣靜脈注射溶液同時投與，包括含鈣溶液持續靜脈輸注，如經由Y 型管投與之非腸道營養。然而，在新生兒以外的病人，如果可以在兩次輸注之間徹底以可相容的溶液沖洗輸注管，則可以相繼使用Ceftriaxone與含鈣溶液(見 2.4.4 與其他藥品交互作用以及其他形式的交互作用)目前並沒有資料顯示靜脈輸注ceftriaxone與口服含鈣產品或肌肉注射ceftriaxone與靜脈注射或口服含鈣產品之間不會發生沉澱。

2.2.1 特殊劑量指示：

肝臟受損病人

病人腎功能正常而肝臟功能有損害時，不需調低劑量

腎臟受損病人

病人肝功能正常而腎功能不全時，不需要減低Ceftriaxone劑量。只有在腎衰竭末期前(肌酸酐清除率小於 10 毫升/分鐘)的情況下，每日劑量不可超過 2 克。病人有嚴重的肝和腎功能不全時，須每隔固定時間測量 ceftriaxone的血漿濃度，如果需要時應調整劑量。

在接受透析的患者不需在透析後給予額外的劑量。然而因爲這些患者的排除速率會有所改變，一般須偵測 ceftriaxone血漿濃度以決定是否需要調整劑量

老年人

服用成人建議劑量，毋需再調整劑量。

兒童

新生兒、嬰兒和至12歲的小孩：下列爲每天給藥1次的建議劑量：

新生兒（至14天）：每日給藥20-50毫克/公斤體重。每日劑量不要超過50毫克/公斤。沒有必要去區分早產兒和足月嬰兒。Ceftriaxone對於需要(或預期需要)接受含鈣溶液治療，包括含鈣溶液持續靜脈輸注如靜脈營養的新生兒(≦ 28 天)爲使用禁忌，因爲會有產生ceftriaxone-calcium沉澱的風險(見 2.3 禁忌)。

新生兒、嬰兒和小孩（15天至12歲）：每日一次20-80毫克/公斤。

小孩體重大於50公斤就必需使用成人的一般劑量。

靜脈注射給藥劑量≥ 50毫克/公斤體重時，必須以輸注法給藥，而且給藥時間至少需超過 30 分鐘。

腦膜炎

嬰兒和小孩的細菌性腦膜炎，剛開始治療時，日劑量爲100 毫克/公斤（最大可至4 克），直到致病菌被鑑定出來，且感受性也被確認後，劑量可依據調低。

在下列的治療期間可獲得很好的治療結果：

腦膜炎雙球菌(Neisseria meningitidis) 4天
感冒嗜血桿菌(Haemophilus influenzae) 6天
肺炎雙球菌(Streptococcus penumoniae) 7天

萊姆病(Lyme borreliosis)

小孩和成人的劑量爲50 毫克/公斤，最多可至2克，每日一次，共14天。

手術周期的預防感染

依據感染的危險性，在開刀前 30-90 分鐘投予單一劑量 Ceftriaxone 1-2 克。在直腸外科手術，投予Ceftriaxone。併用或不併用 5-nitro-imidazole如ornidazole(分開投予，見 2.2 用法用量)，證實可有效的預防感染。

2.3 禁忌(依文獻記載)

已知對cephalosporins抗生素過敏的病人不能使用Ceftriaxone。對penicillin過敏的病人也可能會對Ceftriaxone產生過敏反應。

高膽紅素血症的新生兒和早產而不得使用 Ceftriaxone治療。在體外試驗顯示，ceftriaxone 可從血清 albumin 中將 bilirubin取代出來，導致這些病人可能有發展成膽紅素腦病的風險。

Ceftriaxone禁用於需要(或預期需要)接受含鈣溶液治療新生兒(≦28 天)，包括含鈣溶液持續靜脈輸注如靜脈營養，因爲會有產生ceftriaxone-calcium 沉澱的風險(見 2.2用法用量和 2.4.4 與其它藥品間的交互作用以及其它形式的交互作用)。

在少數併用Ceftriaxone與含鈣溶液的新生兒少數致命的案例中，在解剖報告中，曾在肺及腎觀察到結晶的物體。在某些案例中，Ceftriaxone與含鈣溶液使用相同的輸注管線，在輸注管線中會觀察到一些沉澱。至少有一新生兒死亡報告，是在不同的時間經由不同的輸注管線投與Ceftriaxone及含鈣溶液；在該新生兒案例的解剖報告中並無觀察到結晶的物體。除了新生兒以外，其他病人並無類似的報告(見 2.6.1 上市後經驗)。

2.4 警告及注意事項(依文獻記載)

2.4.1 一般

和其他cephalosporins一樣，在沒有過敏或先前未使用過此類藥物的病人，曾有致命的過敏反應被報導過。

使用 cephalosporin 類的抗菌劑，包括Ceftriaxone的病人，有報導過免疫媒介性溶血性貧血症。在成人與兒童皆有被報導在服藥期間發生嚴重溶血性貧血的案例，包含死亡。如果病人在使用 ceftriaxone 期間產生貧血，必須考慮是否為cephalosporin 引發的貧血，且在確認出貧血的原因之前，必須中止 ceftriaxone的治療。幾乎所有抗菌劑，包括Ceftriaxone皆有發生與 Clostridium difficile 有關的腹瀉(CDAD)的報告，且其嚴重程度可能從輕度腹瀉到致死性結腸炎。抗菌劑的治療會改變正常的腸道菌叢，而導致 C. difficile的過度生長。

C. difficile會製造促成 CDAD產生的毒素 A 和B。會過度產生毒素的C. difficile菌株會增加發病率和致死率，因為這些感染可能難以抗菌劑治療且可能需要結腸切除治療。針對所有使用抗生素後發生腹瀉的病患應考量是否為 CDAD。因為CDAD曾被報導在停用抗菌劑超過 2 個月後發生，因此必須詳細評估其病史。

如果懷疑或確認為 CDAD，目前使用的非針對 C. difficile的抗生素可能也必須終止。必須依照臨床狀況，給予適時的液體或電解質管理、補充蛋白質，給予治療C. difficile的抗生素和建立外科手術的評估。和其他的抗菌劑一樣，也可能受感受性差的微生物(non-susceptible microorganisms)重複感染(superinfection)。

通常給予超過標準建議劑量的劑量後，在作膽道超音波時會看到陰影，而這陰影曾經被誤以為是膽結石。然而事實上，這陰影是ceftriaxone的鈣鹽沈澱物，通常在完成或停止Ceftriaxone的治療後，即可消失。這些現象幾乎沒有併隨臨床症狀。

對有發生臨床症狀的案例而言，建議採取較保守的非外科手術處理。

同時若須藉由停止Ceftriaxone的療程而來改善臨床症狀的案例，則須經由醫師作慎重的判斷。

根據已知的學術資料，給予ceftriaxone及含鈣溶液或其他含鈣的產品，除了新生兒以外，並無血管內沉澱的報告。然而，即使是經由不同輸注管線，ceftriaxone仍不得與含鈣溶液混合或同時注射。(見2.3 禁忌中有關新生兒資訊一段、2.4.4與其它藥品間的交互作用以及其它形式的交互作用和 2.6.1 上市後經驗)。

有極少數使用Ceftriaxone治療的病人有發生膀胱炎的案例，其病因學可能是因為膽道阻塞而引起的。臨床上大部分病人都有造成膽道鬱滯和膽道淤泥的危險因子，例如進行大規模的治療、嚴重疾病和進行全身靜脈營養輸注。Ceftriaxone相關的膽道沈澱物的起因或輔助因子的角色不能被排除在外。Ceftriaxone在新生兒、嬰兒和小孩的安全性和有效性已建立完成，在用法用量的章節有詳細介紹。研究顯示ceftriaxone和其他一些cephalosporins 相同，可從血清albumin中將 bilirubin 取代出來。Ceftriaxone不可用於有發展膽紅素腦病風險的新生兒(尤其是早產兒)(見 2.3 禁忌)。長期治療時，須定期檢查全血球計數。

2.4.2 藥物濫用及依賴性

不適用

2.4.3 駕駛及機器操作能力

沒有數據指出對服用者的駕駛和使用機器的能力有任何影響。

2.4.4 與其他藥品間的交互作用以及其它形式的交互作用

併用大劑量的Ceftriaxone和強效的利尿劑(如：furosemide)，至目前為止的觀察，並沒有傷害腎臟的功能，也沒有證據顯示Ceftriaxone會增加aminoglycosides的腎毒性。使用Ceftriaxone後，喝酒也並不會產生僅使用disulfiram後所引起的副作用。Ceftriaxone不含其他某些cephalosporins中可能會引起的ethanol無法耐受性和出血現象的N-methylthiotetrazole基。Ceftriaxone的排除作用不會被probenecid改變。體外的實驗顯示，併用chloramphenicol和ceftriaxone會有拮抗作用。

不可使用含鈣溶液(例如 Ringer’s 溶液或 Hartmann’s 溶液)配製Ceftriaxone小瓶或進一步稀釋已配製後之小瓶，因為會產生沉澱。當Ceftriaxone與含鈣溶液在同一個靜脈注射管線混合時，也會發生 ceftriaxone-calcium 沉澱。Ceftriaxone不應與含鈣靜脈注射溶液同時投與，包括含鈣溶液持續靜脈輸注，如經由 Y 型管投與之非腸道營養。然而，在新生兒以外的病人，如果可以在兩次輸注之間徹底以可相容的溶液沖洗輸注管，則可以相繼使用 Ceftriaxone與含鈣溶液。根據成人和由臍帶血取得的新生兒血漿的體外研究結果，證實新生兒發生 ceftriaxone-calcium 沉澱的風險較高(見 2.2 用法用量見 2.3 禁忌)。

依據文獻報告，ceftriaxone和amsacrine、vancomycin、fluconazole及aminoglycosides 均不相容。

2.5 特殊族群的使用(依文獻記載)

2.5.1 懷孕

Ceftriaxone會穿透胎盤障壁。對於人類懷孕之安全性尚未建立。以動物實驗來研究生殖能力，沒有證據顯示有胚胎毒性、胎兒毒性、致畸胎性或對男性或女性生育力、生產或週產期(perinatal)和產後的(postnatal)的發育有不良作用。

在靈長類動物並未觀察到胚胎毒性或致畸胎性。

2.5.2 授乳母親

低濃度ceftriaxone會分泌於人類乳汁，授乳婦女務請小心使用Ceftriaxone。

2.5.3 兒童使用

見特殊劑量指示。

2.5.4 老年人使用

見特殊劑量指示。

2.5.5 腎功能受損

見特殊劑量指示。

註 (1)報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

(2)仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。